

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЖЕНСКОЙ ГРУДИ

ABOUT)

CLERY)

IOI

'IE



Женская грудь – эталон сексуальности и красоты. Предназначена для выполнения нескольких физиологических функций, включая выработку молока и кормление новорожденного ребенка.

Под привлекательным внешним видом молочной железы скрывается достаточно сложное строение. Хорошо знать его особенности каждой женщине. Это поможет ей понять, какие изменения происходят в груди, с чем они связаны.

При подозрении на развитие патологии важно вовремя обратиться к врачу-маммологу, обязательно пройти тщательное медицинское обследование.

[ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ](#)

Структура груди

У зрелой женщины молочная железа содержит несколько видов тканей: жировую, железистую, соединительную (фиброзную). Расположена она на грудной мышце, крепится к ней соединительной тканью. В области этого органа находится много лимфатических узлов. Главное назначение железистой ткани – выработка питательного молока. Во время грудного вскармливания она увеличивается, однако по завершению лактации возвращается в прежний размер.

Железистая ткань окружена жировой. Последняя отвечает за объем, а также форму бюста. У каждой женщины соотношение жировой и железистой тканей разное. Кроме того, оно меняется на протяжении всей жизни: с увеличением возраста жировая ткань преобладает. Она постепенно замещает железистую. Происходит это по причине неизбежного возрастного изменения женского гормонального фона. Находясь под давлением долей молочных желез, соединительная ткань надежно их удерживает. Благодаря ее рыхлой структуре женская грудь всегда подвижна.

Как возникает рак груди?

Онкология молочной железы – тяжелая гормонозависимая патология, возникающая из-за мутации клеток человеческого организма. Женские гормоны (гестаген, эстроген) непосредственно влияют на состояние грудной ткани. Процесс воздействия зависит от фазы менструального цикла, а также изменений, связанных с беременностью, родами, лактацией. Иногда случается, что отдельные клетки прекращают подчиняться гормональным сигналам, начинают бесконтрольно размножаться.

Они быстро заполняют грудные протоки и дольки. В итоге появляется злокачественное образование. Рак груди возникает в молочной железе, но при отсутствии эффективной терапии постепенно переходит на иные органы. Спустя некоторое время прогрессирование патологического процесса приводит к смерти. Риск такого заболевания груди у женского пола резко возрастает после сорока лет, достигая максимального уровня.

Онкология молочной железы зачастую возникает незаметно, развивается без выраженных симптомов. Следовательно, всем женщинам необходимо периодически самостоятельно осматривать свою грудь, проходить профилактические медицинские обследования. Квалифицированная консультация маммолога поможет обнаружить патологическую проблему в начале ее развития, провести дополнительные диагностические исследования, при необходимости – своевременную эффективную терапию.

Лечением рака молочной железы и прочих заболеваний женской груди занимается маммолог Бондарь А.В. При постановке диагноза доктор использует следующие методы инструментального обследования:

- УЗИ молочных желез;
- маммографию – рентген груди;
- дуоденальную дуоденографию (рентген протоков грудной железы).

Если обнаружено новообразование, доктор проводит его хирургическое удаление. Инновационные методики оперирования позволяют сохранить основную часть пораженного органа, полностью убрать патологический участок. В большинстве случаев молочная железа сохраняет свой эстетический вид. Внимание! При обнаружении опухоли грудной железы в начальной стадии прогноз благоприятный, существует высокий шанс успешно излечиться, вернуться к привычной деятельности. Помните: своевременная запись к маммологу может спасти вам жизнь!

Как растет грудь?

В процессе полового созревания организм девочки начинает вырабатывать гормон эстроген. Под его воздействием активируется развитие груди: наблюдается набухание молочных желез. Дальнейший их рост делится на такие периоды:

1. 9–10 лет. Девочки с ранним половым созреванием отмечают легкое набухание сосков, изменение цвета ареолы (покраснение).
2. 11–12 лет. Постепенное увеличение груди часто сопровождается неприятными, иногда даже немного болезненными ощущениями. Растягивание кожи может вызывать зуд либо жжение. Соски приобретают округлую форму, грудь становится мягче. Девочки, у которых позднее половое развитие, характерно небольшое уплотнение грудных желез.
3. Начало менструации. Молочные железы становятся болезненными, соски увеличиваются, усиливается пигментация. Кончик груди постепенно превращается в округлую. Ареола слегка темнеет, контур соска иногда покрывается красноватыми пятнами. Это нормальное явление, которое не требует визита к врачу.
4. 14–15 лет. Период ускоренного развития молочной железы, сильного разрастания соединительной ткани. В это время девочки-подростки ощущают дискомфорт, сдавливания в груди. Последнее легко объясняется интенсивным ростом протоков.

Окончательное формирование груди наблюдается ближе к двадцати годам. Она приобретает характерную для себя форму определенных размеров. Процесс развития молочных желез большей частью индивидуален. Обычно он длится от 3 до 5 лет, в редких случаях растягивается на десять.

Интенсивность и скорость увеличения груди у девушек зависит от множества факторов, особенностей каждого развивающегося организма. Несовпадения с вышеизложенным не всегда свидетельствует о наличии отклонений в развитии, каких-либо проблем со здоровьем. При обнаружении значительных отличий требуется посетить маммолога. Он проведет внешний осмотр, при необходимости назначит современные диагностические исследования. На их основании врач может точно сказать, существуют ли отклонения в развитии женской груди.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ

ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ СОСКА

(/blog/vydeleniya-iz-molochnoi-zhelezy)

КРОВЯНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ СОСКА

(/blog/krovnyanye-vydeleniya-iz-grudi-ili-bolezn-minca)

КАК ВЫБРАТЬ БЮСТГАЛЬТЕР?

(/blog/kak-pravilno-vybrat-byustgalter)

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГРУДИ НОРМАЛЬНЫЕ И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ РАКА?

(/blog/kakie-izmeneniya-normalnye-i-ne-yavlyayutsya-priznakami-raka)

СТОИТ ЛИ ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ, ЕСЛИ УПЛОТНЕНИЕ В ГРУДИ НЕ БЕСПОКОИТ?

(/blog/uplotnenie-v-grudi-ne-bespokoit)

ГРУДЬ РАЗНОГО РАЗМЕРА: ПРОБЛЕМА ИЛИ НОРМА?

(/blog/grud-raznogo-razmera-problema-ili-norma)

МАСТОПАТИЯ ГРУДИ И КЛИМАКС

(/blog/mastopatiya-grudi-i-klimaks)

КАК ПОНЯТЬ ЧТО У ЖЕНЩИНЫ МАСТИТ?

(/blog/kak-ponyat-cto-u-zhenshiny-mastit)

БОЛЬ И УВЕЛИЧЕНИЕ ГРУДИ ПРИ КЛИМАКСЕ

(/blog/bol-v-grudi-i-plastika-pri-klimakse)

КОГДА ИДТИ К МАММОЛОГУ?



(/blog/kogda-idti-k-mammologu)

ПОЧЕМУ БОЛИТ ГРУДЬ?

(/blog/bol-v-grudi)

ЧТО ПРОИСХОДИТ С МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗОЙ ПРИ КЛИМАКСЕ?

(/blog/bol-v-grudi-i-plastika-pri-klimakse)

МАСТОПАТИЯ И БЕРЕМЕННОСТЬ

(/blog/mastopatiya-i-beremennost)

АБСЦЕСС МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

(/blog/abscess-molochnoi-zhelezy)

МИФЫ О ЖЕНСКОЙ ГРУДИ

(/blog/mify-o-zhenskoi-grudi)



tp



tp

https://www.facebook.com/aleksandr.bondar/

igshid=ug9b65it3lka)

